

Faringoamigdalitis y otitis media aguda

1. Introducción y relevancia clínica

Las **infecciones respiratorias altas (IRA)** son las causas más frecuentes de consulta pediátrica. Entre ellas, destacan dos entidades comunes y potencialmente complicadas si no se manejan adecuadamente:

- **Faringoamigdalitis aguda (FAA):** inflamación de la mucosa faríngea y amígdalas palatinas.
- **Otitis media aguda (OMA):** inflamación e infección del oído medio, con líquido purulento tras la membrana timpánica.

El desafío clínico radica en **distinguir las causas virales (autolimitadas)** de las **bacterianas (que requieren antibióticos)**, especialmente la **faringoamigdalitis estreptocócica (*S. pyogenes*)** y la **OMA bacteriana**.

En Chile, el manejo racional de antibióticos está normado por las **Guías MINSAL de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y **SOCHIFE 2023**, buscando reducir resistencia antimicrobiana y complicaciones.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a.

Faringoamigdalitis aguda (FAA)

Etiología:

- **Viral (70–80 %):** adenovirus, rinovirus, coronavirus, influenza, EBV (mononucleosis).
- **Bacteriana (20–30 %):** *Streptococcus pyogenes* (grupo A beta hemolítico, EBHGA) → principal patógeno clínicamente relevante.

Mecanismo:

La infección bacteriana o viral produce inflamación faríngea, edema y exudado amigdalár.

En la faringoamigdalitis estreptocócica, la toxina eritrogénica del *S. pyogenes* puede causar escarlatina o fiebre reumática si no se trata.

b.

Otitis media aguda (OMA)

Etiología:

- **Bacterias:** *S. pneumoniae*, *H. influenzae* no tipificable, *M. catarrhalis*.
- **Virus respiratorios** predisponen a disfunción de la trompa de Eustaquio → acumulación de secreción y sobreinfección bacteriana.

Fisiopatología:

- Obstrucción tubárica por resfrío o alergia.
- Acúmulo de secreción en oído medio → presión → inflamación de la mucosa timpánica.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

A.

Faringoamigdalitis

1. Viral:

- Tos, rinorrea, conjuntivitis.
- Odinofagia leve.
- Fiebre baja o ausente.
- Amígdalas eritematosas sin exudado.

2. Bacteriana (EBHGA):

- Fiebre alta >38,5 °C.
- Dolor faríngeo intenso, sin tos.

- Exudado blanquecino en amígdalas.
- Adenopatías cervicales dolorosas.
- En niños pequeños: dolor abdominal, vómitos.

□ En EUNACOM: “Niño con fiebre alta, sin tos, exudado amigdalario y adenopatías cervicales → sospechar EBHGA.”

B.

Otitis media aguda

Clínica típica:

- Fiebre.
- Dolor de oído (otalgia).
- Irritabilidad (en lactantes).
- Disminución de la audición.
- En lactantes: rechazo alimentario, llanto nocturno.
- En casos graves: otorrea (si perfora el tímpano).

Otoscopía:

- Membrana timpánica **eritematosa, abombada, opaca o con nivel líquido**.
- Movilidad disminuida al otoscopio neumático.

□ En EUNACOM: “Lactante febril, irritable, con membrana timpánica eritematosa y abombada → otitis media aguda.”

C.

Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características diferenciales
Mononucleosis infecciosa (EBV)	Exudado amigdalар + adenopatías generalizadas + hepatoesplenomegalia
Adenovirus	Conjuntivitis + faringitis
Sinusitis / otitis serosa	Dolor leve o hipoacusia sin fiebre
Otitis externa	Dolor al traccionar pabellón, sin fiebre ni exudado timpánico

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

A.

Faringoamigdalitis

1.

Criterios de Centor modificados

Criterio	Puntaje
Fiebre >38 °C	+1
Ausencia de tos	+1
Exudado amigdalар	+1

Adenopatías cervicales anteriores dolorosas +1

Edad 3–14 años +1

Edad >45 años –1

- - 0–1 puntos:** no antibiótico ni test.
- **2–3 puntos:** test rápido de antígeno o cultivo faríngeo.
- **≥4 puntos:** tratar empíricamente con antibiótico.

2.

Test rápido o cultivo faríngeo

- Cultivo: gold standard, demora 24–48 h.
 - Test rápido: especificidad >95 %, sensibilidad 70–90 %.
-

B.

Otitis media aguda

Diagnóstico clínico (no requiere laboratorio).

Se basa en:

1. Presencia de **líquido en oído medio** (nivel, movilidad disminuida).
 2. **Signos de inflamación timpánica.**
 3. **Síntomas agudos** (fiebre, otalgia, irritabilidad).
-

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / SOCHIPE 2023)

A.

Faringoamigdalitis

1.

Viral:

Tratamiento sintomático:

- Antipiréticos (paracetamol, ibuprofeno).
- Hidratación y reposo.
- No requiere antibióticos.

2.

Bacteriana (EBHGA):

Primera elección:

- **Penicilina benzatina IM dosis única:**
 - <30 kg: 600.000 UI.
 - ≥30 kg: 1.200.000 UI.
 - Alternativa: **amoxicilina VO 50 mg/kg/día** (máx. 1 g) × 10 días.

Alergia a penicilina:

- Azitromicina 10 mg/kg/día × 5 días.
- Clindamicina 20 mg/kg/día × 10 días.

Objetivos:

- Prevenir fiebre reumática.
 - Reducir contagio y duración de síntomas.
-

B.

Otitis media aguda

1.

Observación vs. antibióticos

- En >2 años, fiebre <39 °C y síntomas leves → observación 48 h.
- En <2 años o síntomas graves → antibióticos inmediatos.

2.

Antibióticos:

- Amoxicilina 80–90 mg/kg/día VO por 10 días.
- Si falla o recidiva: amoxicilina-ácido clavulánico.
- Alternativas: cefuroxima o ceftriaxona IM (casos graves o vómitos).

3.

Tratamiento sintomático

- Analgésicos/antipiréticos.
- Compresas tibias locales.
- No usar gotas óticas antibióticas si membrana íntegra.

6. Complicaciones y pronóstico

Enfermedad	Complicaciones	Pronóstico
Faringoamigdalitis estreptocócica	Fiebre reumática, glomerulonefritis, absceso periamigdalino	Excelente con antibiótico precoz

Otitis media aguda

Mastoiditis, meningitis, hipoacusia,
otitis media serosa

Buena con
tratamiento oportuno

Seguimiento:

- Reevaluar en 48–72 h si no hay mejoría.
 - Control auditivo en otitis recurrentes.
-

7. Prevención

- Vacunación contra influenza, neumococo y Hib.
 - Evitar exposición a humo de tabaco.
 - Lactancia materna exclusiva (disminuye OMA).
 - Educación en lavado de manos y uso racional de antibióticos.
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Causa más común de FAA bacteriana:** *S. pyogenes* (EBHGA).
2. **Tratamiento de elección:** penicilina benzatina IM dosis única.
3. **Antibióticos en OMA:** amoxicilina alta dosis (80–90 mg/kg/día).
4. **Criterios de Centor** guían decisión terapéutica.
5. **Otitis media:** diagnóstico clínico, no requiere laboratorio.
6. **Fiebre reumática** es complicación prevenible con penicilina.
7. **En menores de 2 años:** iniciar antibióticos en OMA siempre.

❑ Errores frecuentes:

- Tratar todas las FAA con antibióticos.
 - Usar macrólidos de primera línea sin alergia.
 - No completar los 10 días de antibiótico.
 - Diagnosticar otitis sin confirmación otoscópica.
 - Omitir reevaluación tras 48 h de observación.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Faringoamigdalitis viral** es la más común; solo estreptocócica requiere antibiótico.
2. **Criterios de Centor** orientan el tratamiento.
3. **Penicilina benzatina** es primera elección en FAA estreptocócica.
4. **Otitis media aguda**: antibióticos solo en <2 años o casos graves.
5. **Amoxicilina alta dosis (80–90 mg/kg/día)** es el fármaco de elección.
6. **Complicaciones prevenibles** con diagnóstico y tratamiento precoz.
7. **Vacunación y lactancia materna** reducen incidencia de OMA.